

Trastorno psicótico agudo

1. Introducción y relevancia clínica

El **trastorno psicótico agudo** representa una de las urgencias psiquiátricas más relevantes en la práctica médica.

Se caracteriza por la aparición súbita (en horas o días) de **síntomas psicóticos —delirios, alucinaciones o conducta desorganizada—** en un paciente previamente funcional.

Es una entidad de diagnóstico clínico, y su reconocimiento precoz es fundamental, ya que:

- Puede corresponder a un **cuadro psiquiátrico primario (esquizofrenia, trastorno bipolar)** o a una **causa médica o tóxica** (delirium, intoxicación, encefalitis, hipertiroidismo, etc.).
- El tratamiento inmediato **previene daño autoinfligido o heteroagresivo**.
- Su adecuada evaluación inicial orienta el pronóstico y la necesidad de hospitalización.

Relevancia clínica

- Es causa frecuente de ingreso psiquiátrico en Chile.
- Se presenta habitualmente entre los **15 y 35 años**.
- Hasta un **30% de los casos iniciales de esquizofrenia** debutan como un episodio psicótico agudo.
- Es un tema de alta frecuencia en el **EUNACOM clínico y ECOE**, dado que exige reconocer la urgencia, excluir causas médicas y elegir el manejo farmacológico inicial correcto.

☐ La prioridad inicial es **proteger la seguridad del paciente y terceros**, asegurar la causa médica, y tratar de manera rápida y compasiva.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El término “psicosis” no describe una enfermedad específica, sino un **síndrome clínico** que puede tener múltiples etiologías.

2.1. Bases neurobiológicas

- **Hiperactividad dopaminérgica mesolímbica** → delirios y alucinaciones.
- **Hipoactividad dopaminérgica mesocortical** → síntomas negativos (aplanamiento, retraimiento).
- **Alteraciones serotoninérgicas y glutamatérgicas** → modulan percepción y cognición.
- **Factores de estrés agudo** o consumo de sustancias pueden precipitar un episodio psicótico transitorio.

2.2. Clasificación según DSM-5-TR

Diagnóstico	Duración	Características principales
Trastorno psicótico breve	< 1 mes	Inicio súbito, recuperación completa.
Trastorno esquizofreniforme	1–6 meses	Similar a esquizofrenia, curso limitado.
Esquizofrenia	> 6 meses	Síntomas persistentes, deterioro funcional.
Trastorno esquizoafectivo	Variable	Psicosis + síntomas afectivos (depresivos o maníacos).
Psicosis inducida por sustancias o enfermedad médica	Variable	Relación temporal clara con tóxico o causa orgánica.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Síntomas psicóticos principales

Tipo	Descripción	Ejemplo
Delirios	Creencias falsas, irreductibles a la lógica o evidencia.	“Me están vigilando”, “soy elegido por Dios”.
Alucinaciones	Percepciones sin estímulo externo. Predomina la auditiva .	Voces que comentan o insultan.
Trastornos del pensamiento	Incoherencia, fuga de ideas, neologismos.	“El sol habla conmigo a través del reloj del tiempo.”
Conducta desorganizada o catatónica	Actos extraños, agitación, inmovilidad o mutismo.	Posturas rígidas, resistencia a moverse.
Síntomas negativos	Aplanamiento afectivo, anhedonia, retraimiento.	Falta de expresión, poco contacto visual.

3.2. Evolución clínica típica

1. **Pródromo:** ansiedad, insomnio, irritabilidad, aislamiento.
 2. **Episodio agudo:** delirios, alucinaciones, desorganización conductual.
 3. **Resolución parcial o completa** (en días o semanas).
-

3.3. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Elementos distintivos
Delirium	Fluctuación de conciencia, desorientación, causa médica.
Psicosis inducida por sustancias	Relación temporal con cocaína, anfetaminas, cannabis o LSD.
Trastorno bipolar (episodio maníaco con psicosis)	Euforia, fuga de ideas, aumento de energía.
Depresión psicótica	Delirios congruentes con ánimo (culpa, ruina).
Epilepsia del lóbulo temporal / encefalitis	Focalidad neurológica, fiebre o crisis.
☐ “Toda psicosis de inicio súbito y primera vez es un diagnóstico médico hasta que se descarte una causa orgánica.”	

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación médica inicial

- **Glicemia capilar y signos vitales.**
- **Examen físico y neurológico completo.**
- **Evaluación toxicológica:** orina (cocaína, anfetaminas, cannabis, benzodiacepinas).
- **Laboratorios básicos:** hemograma, electrolitos, urea, creatinina, perfil hepático y TSH.
- **Neuroimagen (TAC o RM cerebral)** si hay debut atípico, signos focales o convulsiones.
- **EEG** si sospecha epilepsia o encefalopatía.

4.2. Criterios diagnósticos DSM-5 (Trastorno psicótico breve)

- Presencia de ≥ 1 de los siguientes síntomas (uno debe ser 1, 2 o 3):
 1. Delirios.
 2. Alucinaciones.
 3. Lenguaje desorganizado.
 4. Conducta marcadamente desorganizada o catatónica.
- Duración mínima de 1 día y < 1 mes.
- Retorno completo al nivel previo de funcionamiento.
- No atribuible a sustancias o enfermedad médica.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El objetivo es **controlar los síntomas psicóticos, proteger la seguridad** del paciente y **establecer el diagnóstico de base**.

5.1. Medidas iniciales

- Asegurar un **ambiente tranquilo y seguro**.
- Supervisión constante por riesgo de agitación o agresión.
- Retirar objetos peligrosos.
- Contención verbal y física si es necesario (siguiendo protocolos).
- Evaluar riesgo suicida o de heteroagresión.

5.2. Tratamiento farmacológico

El **antipsicótico atípico** es el pilar del manejo inicial.

Primera línea (vía oral, si el paciente coopera)

Fármaco	Dosis inicial	Comentarios
Risperidona	1–2 mg VO cada 12 h (máx 6 mg/día)	Buen perfil de eficacia y tolerancia.
Olanzapina	5–10 mg VO al día	Sedante, útil en agitación.
Quetiapina	50–100 mg VO c/12h	Menos riesgo extrapiramidal, más sedante.

Si no coopera o presenta agitación severa

Situación	Fármaco	Dosis	Comentario
Agitación psicótica grave	Haloperidol 5 mg IM + Biperideno 2 mg IM	Repetir cada 30–60 min (máx 20 mg/24h).	Evita distonías.
Alternativa	Olanzapina IM 10 mg	Única dosis efectiva.	No combinar con benzodiacepinas IM.

Asociaciones útiles

- **Lorazepam 1–2 mg IM o VO** si hay ansiedad o agitación concomitante.
 - **Evitar benzodiacepinas solas** en psicosis primaria (pueden empeorar delirios).
-

5.3. Hospitalización

Indicada cuando existe:

- Riesgo de suicidio o heteroagresión.
- Desorganización conductual severa.
- Negativa a tratamiento o falta de juicio crítico.
- Duda diagnóstica médica o intoxicación.
- Ausencia de red de apoyo o contención familiar.

En Chile, puede realizarse **hospitalización involuntaria** (Ley 21.331) cuando hay riesgo vital y el paciente no consiente.

5.4. Tratamiento de mantenimiento

Una vez controlada la crisis:

- Continuar antipsicótico al menos **4–6 semanas** tras la remisión total.
 - Si es primer episodio, mantener tratamiento por **1 año** antes de intentar retiro.
 - Psicoterapia de apoyo y psicoeducación familiar.
 - Derivación a programa de salud mental o COSAM.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Agitación psicomotora o agresividad.
 - Reacciones distónicas o acatisia por haloperidol.
 - No adherencia al tratamiento → recaídas frecuentes.
 - Cronificación hacia esquizofrenia (20–30%).
 - Riesgo suicida elevado en las fases iniciales o postcrisis.
-

Pronóstico

- **Trastorno psicótico breve:** recuperación completa en semanas.
- **Esquizofreniforme:** evolución incierta; 50% evolucionan a esquizofrenia.
- **Psicosis secundaria:** depende de la causa (bueno si se elimina el tóxico o se trata la patología médica).

Factores de buen pronóstico:

- Inicio abrupto.
- Buena red de apoyo.
- Síntomas emocionales concomitantes (versus embotamiento afectivo).
- Ausencia de antecedentes familiares de esquizofrenia.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Toda psicosis de **inicio súbito** debe considerarse **de causa médica o tóxica hasta demostrar lo contrario**.
 2. En pacientes con **agitación psicótica grave**, la combinación **haloperidol + biperideno** sigue siendo segura y efectiva.
 3. **Olanzapina IM** es útil, pero **nunca debe combinarse con benzodiacepinas IM**.
 4. **Neuroimagen** está indicada en todo primer episodio psicótico.
 5. En el **EUNACOM**, ante duda, la hospitalización psiquiátrica es la conducta correcta.
 6. Tras la crisis, mantener tratamiento **mínimo 1 año** antes de reducir dosis.
 7. La **falta de juicio de realidad** es el elemento definitorio del episodio psicótico.
-



Errores comunes

- No descartar causas médicas o tóxicas.
 - Usar benzodiacepinas sin antipsicóticos en psicosis primaria.
 - Omitir biperideno junto a haloperidol.
 - Suspender antipsicóticos precozmente tras mejoría.
 - No documentar evaluación de riesgo suicida o de violencia.
 - No educar al paciente y familia sobre adherencia.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **trastorno psicótico agudo** es una **emergencia psiquiátrica** caracterizada por delirios, alucinaciones o desorganización conductual de inicio súbito.
2. Siempre se debe **descartar causa médica o tóxica** antes de asumir origen primario.
3. El tratamiento inicial incluye **antipsicóticos atípicos** (risperidona, olanzapina) o **haloperidol IM + biperideno** si el paciente no coopera.
4. La **hospitalización** está indicada si hay riesgo suicida, agitación grave o falta de juicio.
5. **Neuroimagen y tóxicos en orina** son obligatorios en todo primer episodio.
6. La **recuperación completa** es posible en cuadros breves, pero existe riesgo de cronificación.
7. El **seguimiento prolongado y la adherencia** son claves para prevenir recaídas.